

시험 관령 코멘트



피로는 비특이적 증상으로 증상의 지속 기간에 따라 1개월 미만 지속되는 피로를 급성 피로, 6개월 이상 지속되는 피로를 만성 피로로 정의합니다. 피로를 유발하는 질환에는 기질적 원인과 그 외 신경, 정신적 원인, 약물 사용, 원인불명 등 다양한 원인이 존재합니다. 따라서 기질적 원인이 의심될 시 계통별로 질문을 해야 하며, 원인불명의 피로의 경우 대표적으로 만성 피로증후군을 의심해 진단 기준 증상 8가지 중 4개 이상을 만족 시 진단을 내릴 수 있습니다.

문진 시 정신과 질환에 대해 감별해야 한다는 것을 명심하고, 이전에 건강 검진을 받은 적이 있는지를 꼭 물어봐야 합니다.

신체 진찰 시 갑상샘저하증을 감별하기 위해 목 진찰을 하는 것을 잊지 맙시다. 그 외 환자가 호소하는 증상에 따라 신체 검진이 달라질 수 있습니다.

환자 교육이 중요한 파트로 올바른 생활 교육을 하는 것이 중요합니다. 음주를 줄이고, 야식을 끊어야 하며, 규칙적인 운동으로 체중 조절과 충분한 수면을 취해야 합니다. 생활 습관을 교정했음에도 코골이 증상이 좋아지지 않는다면 CPAP 등의 치료가 필요할 수도 있습니다. 또한 카페인 섭취가 수면을 질을 떨어뜨릴 수 있으므로 카페인 섭취 감량을 권유해야 합니다. 큰 병이 아닐 경우 안심시켜 주는 것도 필요하겠습니다.

원인 감별과 환자 교육으로 시간이 빠듯한 모듈이니 다양한 감별 진단에 대해 골고루 질문하면서 시간 조절을 하시는 것이 좋습니다.

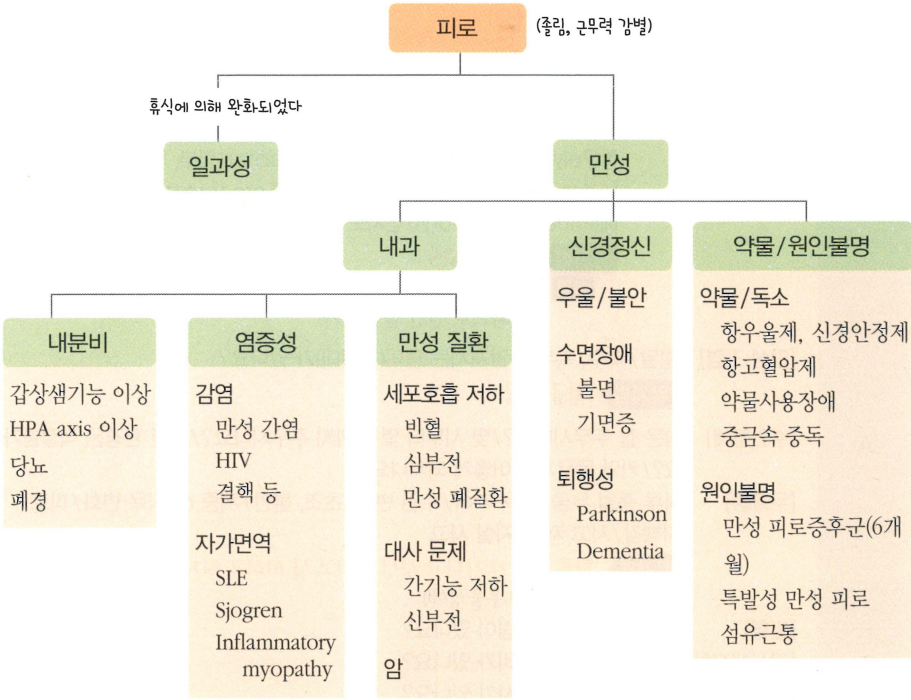
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
정신과		일과성 피로	[병력] 너무 무리해서 피곤한 것, 사회력 중요, 피로 외 다른 증상 ×, 휴식에 의한 완화	[치료] 휴식, 안심시키기, 규칙적 식사, 충분한 수면, 적절한 운동
		주요 우울증 / 수면장애* (해당 항목 참조)	[병력] 우울, 식욕 저하, 의욕 저하, 체중 감소, 불면, 만성 피로 [검진] 신체 진찰 정상	[검사] Beck의 우울척도검사 [치료] SSRI, 증상이 심한 경우 입원 치료

정신과	만성 피로증후군★ (chronic fatigue syndrome) (4~8개월)	[병력] (인기다경근두운잠) 전신 근육통, 인후통, 운동 후 권태감, 6개월 이상 지속, 다른 문제 없음 [검진] 신체 진찰 정상	[검사] 다른 검사 진행 후 배제 진단 [치료] 규칙적 식습관, 유산소 운동, 수면 위생, 항우울제, 인지 행동 치료
	섬유근통★ (fibromyalgia)	[병력] 피로, 근골격계 통증, 의식 혼탁, 수면장애, 감각이상, 집중력 저하 [검진] CBC, ESR, CRP 등 주로 정상	[검사] 임상 증상으로 진단 [치료] 환자 교육, 보존적 치료
내분비	에디슨병 (addison's disease)	[병력] 메스꺼움, 구토, 체중 감소, 피부 착색 [검진] 입 점막 주위 착색	[검사] 혈중 코티솔 농도, ACTH 농도, ACTH 투여 후 코티솔 농도 검사 [치료] Hydrocortisone, Prednisone
	갑상샘저하증★ (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 변비, 체중 증가, 피부 푸석 [검진] 갑상샘 종대되어 있을 수도	[검사] 갑상샘기능검사 [치료] Levothyroxine
종양	종양	[병력] 체중 감소, 장기 이상 증상	[검사] Tumor marker, PET/CT [치료] 수술, 항암 치료, 방사선 치료
호흡기	폐결핵★ (tuberculosis)	[병력] 발열, 객혈, 피로, 체중 감소, 야간 발한, 이전에 결핵 걸렸던 적 있음 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 객담 항산염색, 투베르쿨린 검사 [치료] 항결핵제(Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide, Ethambutol)
순환기	빈혈 (anemia)	[병력] 호흡곤란, 피로, 어지럼, 위수술력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, PBS, 혈중 Fe/TIBC/Ferritin [치료] 철분 보충, 코발아민/비타민 B ₁₂

순환기	울혈 심부전 (chronic heart failure)	[병력] 호흡곤란, 오목 부종, 체중 증가 [검진] 경정맥 확장, 심잡음	[검사] 심초음파, 심전도 [치료] Nitrate, 이뇨제
소화기	만성 간염 (chronic hepatitis)	[병력] 황달, 이상한 음식 먹은 것 [검진] 간비대, 황달, 복수	[검사] 간기능검사, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV [치료] 리바비린, 엔테카비어 등

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 피로감이 느껴졌나요? (6개월이 지났는지?)
L	어떤 상황에서 피곤하셨나요?
D	하루 종일 피곤한가요? or 간헐적으로 피곤한가요? 아침에 더 피곤한가요?
Co	점점 더 피로감이 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?
C	[양상] 어떤 증상을 피로하다고 하시는건가요? → 팔다리 근력(힘) 감소, 호흡곤란(숨 참), 집중력 저하, 수면 부족 암기법 ▶ 힘을 숨기고 집중해서 잠을 잔다. 하루 중 언제 가장 심하신가 [정도] 일상 생활에 지장이 있나요?
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [만성 피로증후군] 운동 후 심한 권태감(Exhausted)/근육통(Muscle pain)/다발성 관절 통(Polyarthralgia)/새로운 두통(Headache)/경부, 액외부 림프절 압통(Adenopathy or tender LN)/인후통(Sore throat)/기억력, 집중력장애(Impaired memory)/잠자도 피곤하신가요(Sleep problems)? 암기법 ▶ EMPHASIS 설명 위 8가지 증상 중 4가지 이상이 동시에 6개월 이상 지속 & 타 질환으로 원인 설명 불가 [만성 간염] 황달/복수/복부에 만져지는 덩이(간비대)가 있나요? 암기법 ▶ 황금 복덩이 [수면장애] 잠은 잘 주무시나요?/몇 시부터 몇 시까지 주무시나요?/수면 환경은 적절한가요?/키와 몸무게가 어떻게 되시나요? [우울증] 하루 종일 우울/의욕 저하/수면 변화/초조, 불안/체중 or 식욕 변화/피로/자책감/사고 저하/자살 사고 암기법 ▶ 하루 살이가 자다가 정신 차리고 살 찌려고 피자 사먹자 (MDD=주요우울장애) [빈혈] 호흡곤란/어지럼이 있나요? [갑상샘저하증] 추위불내성/변비가 있나요? [갑상샘항진증] 더위불내성/설사가 있나요? [결핵] 야간 발한/호흡곤란/기침/가래/인후통이 있나요? [CHF] 오목 부종/체중 증가가 있나요? 암기법 ▶ 간수 우변이가 갑질을 결심

F	[스트레스] 스트레스를 많이 받으셨나요? [완화] 휴식한 뒤에는 호전이 되나요?/운동한 뒤에 호전되나요? [악화] 피로를 악화시키는 요인이 있나요?
E	이전에 건강 검진을 받으신 적 있나요? (빈혈, 간질환)
외	[수술] 이전에 위절제술을 받으신 적 있나요?
과	진단 받은 질병이 있으신가요? (HTN, Tb, 갑상샘, 간, 우울증, 수면장애)
약	복용 중인 약물이 있나요? (항고혈압제, 항우울제, 약물 남용)
사	술, 담배 하시나요?/커피는 드시나요?/직업이 어떻게 되시나요?/운동은 하시나요?
	[식습관] 영양 상태는 어떠세요?
가	가족분들 중에 암/결핵을 앓으셨던 분이 계신가요?
여	월경과다가 있나요?
P/E	☞ 환자가 호소하는 증상에 따라 해야 할 신체 검진이 달라질 수 있습니다. 비교적 흔하게 발생하는 갑상샘저하증을 감별하기 위해 목 진찰을 꼭 하고, 그 외 흉부나 복부, 사지 진찰 중에서 시간에 맞게 선택적으로 시행하도록 합니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 구강 점막(색깔 변화) 3. 목★: 갑상샘, 림프절 비대 4. 피부 : 색 변화, 선조 5. 흉부 : 심음, 호흡음 청진 [누워서] 6. 복부 : 시-청-타-촉(간비대) 7. 사지 : 하지 부종/근력 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	피로한 증상이 시간이 지나도 나아지지 않아 걱정이 많이 되셨을 텐데요.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 000 한 이유로 현재 만성 피로증후군이 가장 의심됩니다. 이 질환은 신체에 다른 원인 없이 환자분께서 보이는 피로, 000 증상들 4가지 이상이 동시에 지속적으로 나타날 때 진단을 내릴 수 있습니다.
감별 진단	환자분께서 현재 신체적 원인이 없더라도 다른 증상이 없지는 않은지 나타날 때까지 한동안 지켜보는 것이 필요합니다. 기질적인 원인의 질병으로 B질환, C질환 등 다른 기저 질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 전체혈구검사, 갑상샘기능검사, 간기능검사, 혈중 코티솔 농도검사, 결핵반응검사, 흉부 엑스레이, 혈중철농도검사를 해보도록 하겠습니다.
치료	만약 검사 후 특별한 기저 질환 없이 피로하다면 항우울제나 인지 행동 치료가 도움이 될 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 교정] 피로의 가장 중요한 치료는 생활 습관의 교정입니다. 극복 가능한 정도의 적절한 유산소 운동을 하루 30분씩이라도 규칙적으로 하시는 것이 도움이 많이 됩니다. 또한 음주와 늦은 시간에 야식을 먹는 것은 피로를 악화시킬 수 있으므로 줄이는 것이 좋습니다. [약물 위험성 교육] 약물은 처방해드린 것 이상으로 드시지 마시고, 수면을 방해할 수 있으니 커피도 많이 드시지 마세요. [수면 위생] 수면 환경은 조용하고 쾌적하게 유지해 주시고, 잠이 안 올 때에는 계속 누워 있기보다 침실 밖으로 나와서 명상을 하거나 따뜻한 물을 한 잔 마셔주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, TFT, LFT, fasting serum glucose
- ② Thyroid scan, 수면다원검사, EKG, BDI(우울증 척도검사), Chest X-ray(결핵), 객담도말검사, AFB 검사

❖ 치료 계획

- ① 인지행동 치료
- ② 만성 피로증후군 : 항우울제, 저용량 부신겉질 호르몬
- ③ 수면장애 : 수면 환경 개선
- ④ 철결핍빈혈 : 철분제 보충

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 환자가 극복 가능한 적절한 유산소성 운동 권장
- ② 약물 남용 금지하고, 커피도 많이 마시지 말 것
- ③ 수면장애가 심한 경우 수면다원검사 등 추가적 검사를 받고 수면 위생을 잘 지키도록 교육
- ④ 원인이 밝혀지지 않은 경우 추가적인 검사 및 추적 관찰이 필요함을 교육
- ⑤ 종양과 같은 기질적 원인이 의심되는 경우 그에 대한 검사가 필요함을 교육



keyword

주의 신체적 원인이 없더라도 정신적 원인이라 강조하지 않습니다.

참고 멘트 “의학적으로 특별한 이상 소견은 없습니다만, 그렇다고 아무 문제가 없다는 것은 아닙니다. 다른 증상이 나타날 때까지 한동안 지켜보는 기간이 필요합니다. 심리적인 문제의 경우 저절로 회복되는 것을 기대할 수도 있습니다.”

피로의 지속 기간에 따라 급성 피로, 만성 피로를 구분하고, 피로의 유발 원인 유무에 따라 기질성 피로, 약물/독소 유발, 원인불명 피로 등 감별하기

문진 : 복용 중인 약, 최근 건강 검진 여부 묻기, 정신과 질환(우울/불안, 수면장애, 퇴행성 질환) 감별해야 하는 것 잊지 말기

신체 진찰 : 갑상샘저하증 감별하기 위해 목 진찰하는 것 잊지 말기

환자 교육 : 규칙적 운동, 음주 줄이기, 야식 끊기 등 생활 습관의 교정, 카페인 섭취를 포함한 약물 과다 섭취 피하기, 수면 위생에 대해 교육하기



1) 가장 핵심이 되는 만성 피로와 관련된 증상은 다음과 같이 정의된다.

- 임상적으로 평가되었고, 설명이 되지 않는 새로운 피로가 6개월 이상 지속적 혹은 반복적으로 나타나고
- 현재의 힘든 일 때문에 생긴 피로가 아니어야 하고
- 휴식으로 증상이 호전되지 않아야 하고
- 만성 피로 때문에 직업, 교육, 사회, 개인 활동이 증상이 나타나기 이전에 비해 실질적으로 감소해야 한다.

2) 1)의 피로 이외에 다음 증상들 중 4가지 이상이 동시에 6개월 이상 지속되어야 한다.

[인기다경 근두운잠]

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ① 인후통 | ② 기억력 혹은 집중력 장애 |
| ③ 다발성 관절통 | ④ 경부 혹은 액와부 림프샘 압통 |
| ⑤ 근육통 | ⑥ 새로운 두통 |
| ⑦ 운동 혹은 힘들여 일을 하고 난 후 나타나는 심한 권태감 | |
| ⑧ 잠을 자도 상쾌한 느낌이 없음 | |

3) 하지만 위의 증상들이 다음 나열되는 질환에 의한 것이면 만성 피로증후군에 해당되지 않는다.

- 만성 피로를 설명할 수 있는 현재 증상의 모든 기질적 질환 : 갑상샘저하증, 빈혈, 각종 만성 질환, 부신결절기능저하증, 수면무호흡증, 기면발작, 약물 부작용 등
- 과거에 진단되었지만 회복이 증명되지 않았고, 지속되었을 때 만성 피로를 설명할 수 있는 모든 기질적 질환
- 정신과적인 주요 우울증, 양극성 정동성 장애, 조현병(정신분열증), 망상장애, 치매, 신경성 식욕부진, 대식증
- 만성 피로가 시작되기 2년 전부터 그 이후에 생긴 알코올 혹은 기타 약물 남용
- 심한 비만(체질량 지수 45 이상)

[네이버 서울대병원 의학정보]